

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19^ο

ΤΡΑΥΜΑ & ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ



“Le sort des blessés dépend souvent du premier pansement.”
«Η μοίρα των τραυματιών εξαρτάται συχνά από τον πρώτο επίδεσμο.»

Dominique Jean Larrey, 1766-1842.

ΘΛΑΣΤΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ



Σε ποιες περιπτώσεις αποφεύγεται η συρραφή τραύματος...



- ▶ Ρυπαρό τραύμα, με φλεγμονώδη στοιχεία, νεκρώσεις και ιστικά ράκη.
- ▶ Τραύμα συνθλιπτικό, στο οποίο υπάρχει μεγάλη ιστική καταστροφή.
- ▶ Τραύμα που έλαβε χώρα σε διάστημα μεγαλύτερο των 12-24 ωρών (βλ. παρακάτω).
- ▶ Δάγκωμα (δήγμα) ζώου· εκτός εάν το τραύμα είναι εκτεταμένο, οπότε τοποθετούμε 1-3 μεμονωμένα ράμματα, απλώς για τη συμπλησίαση των τραυματικών χειλέων και τοποθετούμε 1-2 σωλήνες Penrose για παροχέτευση, που αφαιρούνται σε 4-5 ημέρες.
- ♦ **Αντισηψία:** Πρέπει να είναι προσεκτική και επιμελής όσο επιπόλαιο και αν μας φαίνεται ένα θλαστικό τραύμα. Με ένα ήπιο αντισηπτικό διάλυμα διαβρέχουμε το τραύμα και ξεπλένουμε επαρκώς με φυσιολογικό ορό ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω ιστική βλάβη. Ήπια αντισηπτικά για χρήση εντός του τραύματος, συχνότερα, είναι το **Octenisept** και λιγότερο συχνά το **αραιωμένο διάλυμα Betadine**. Αποφεύγεται η χρησιμοποίηση εντός του τραύματος ισχυρών αντισηπτικών τα οποία προορίζονται για εξωτερική χρήση.
- ♦ **Αναλγησία:** Αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο σε οποιονδήποτε τραυματισμό, είτε πρόκειται για ένα απλό, μικρό, θλαστικό τραύμα, είτε για αντιμετώπιση πολυτραυματία ασθενούς! Στα θλαστικά τραύματα διηθούμε τοπικά με **Ξυλοκαΐνη 2%**. Το αναισθητικό ενίεται είτε τοπικά κατά μήκος των χειλέων του τραύματος ή στελεχιαία εκεί όπου διέρχεται ο κλάδος του νεύρου της περιοχής. Σε τραυματισμούς δακτύλων προτιμάται η στελεχιαία αναισθησία με έγχυση Ξυλοκαΐνης στη μεσοδακτύλια πτυχή εκατέρωθεν του πληγέντος δακτύλου. Σε περίπτωση πολυτραυματία, με θλαστικά τραύματα ή πολλαπλές συνοδές κακώσεις (π.χ. κατάγματα), εκτός από περιοχική αναισθησία, επιχειρούμε και αναλγησία με τη χορήγηση ενδοφλεβίως ΜΣΑΦ, Παρακεταμόλης ή αν απαιτείται και Τραμαδόλης.

Συρραφή τραυμάτων (Χρονικό περιθώριο συρραφής / Είδος ράμματος / Χρόνος κοπής).

ΑΚΡΑ	6-10 h	Nylon 2/0, 3/0. Αφαίρεση ραμμάτων σε 10-15 ημέρες.
ΚΟΡΜΟΣ - ΡΑΧΗ	8-10 h	Nylon 2/0, 3/0. Αφαίρεση ραμμάτων σε 7-10 ημέρες.
ΠΕΡΙΝΕΟ	6-8 h	Nylon 2/0, 3/0. Αφαίρεση ραμμάτων σε 7-10 ημέρες.
ΠΡΟΣΩΠΟ - ΠΑΡΕΙΑ	12-24 h	Nylon 4/0, 5/0. Αφαίρεση ραμμάτων σε 4-7 ημέρες.
ΒΛΕΦΑΡΑ - ΟΦΡΥΕΣ	12-24 h	Nylon 6/0, 7/0. Αφαίρεση ραμμάτων σε 4-7 ημέρες.
ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΩΤΟΣ	12-24 h	Nylon 5/0, 6/0. Αφαίρεση ραμμάτων σε 7-10 ημέρες.
ΚΕΦΑΛΗ	12-24 h	Μετάξι (Silk) 2/0, 3/0. Αφαίρεση ραμμάτων σε 5-7 ημέρες.
ΣΤΟΜΑ - ΧΕΙΛΗ	24 h	Safil quick ή Vicryl rapid 3/0, 4/0. Ταχέως απορροφήσιμα.

- Τα μη απορροφήσιμα ράμματα από μετάξι (silk) χρησιμοποιούνται πλέον μόνο για τη συρραφή θλαστικών τραυμάτων στο τριχωτό της κεφαλής. Έχουν καλή συμπεριφορά στον χειρισμό τους και στον σχηματισμό κόμπων, αλλά προκαλούν μεγαλύτερη ιστική αντίδραση (εξαιτίας του πρωτεϊνικού υλικού) από τα συνθετικά ράμματα και ευνοούν την εμφάνιση λοιμώξεων, λόγω υλικού, του τριχοειδικού μηχανισμού που προκαλεί η πλέξη τους και της δημιουργίας biofilm.
- Αν το τραύμα είναι βαθύ και πρέπει να συρράψουμε τον υποδόριο ιστό και τις περιτονίες, τότε χρησιμοποιούμε συνθετικά απορροφήσιμα ράμματα (Vicryl, Vicryl rapid 3/0 ή 4/0, Monocryl, Dexon, κ.ά.), γιατί προκαλούν μικρότερη ιστική αντίδραση από άλλα απορροφήσιμα ράμματα.
- Στο πρόσωπο, δέον είναι, τα ράμματα να αφαιρούνται ανά δύο εναλλάξ, κάθε 2 ημέρες, για καλύτερο επουλωτικό και αισθητικό αποτέλεσμα (ειδικά σε νεότερους ασθενείς).
- Σε ορισμένες περιπτώσεις (εκτεταμένο/αιμορραγόν τραύμα, παχύς-σκληρός-οιδηματώδης ιστός, καθαρό τραύμα κεφαλής χωρίς ξύρισμα) η συρραφή επιτυγχάνεται με μεταλλικά τσιμπιδάκια (clips). Τα clips αφαιρούνται συνήθως στις 7-14 ημέρες (15-21 ημέρες σε ειδικές περιπτώσεις), αναλόγως του είδους και της περιοχής τραύματος, με ειδικό εργαλείο-εξωλκέα (παπαγαλάκι).

